

*Curso*

# **ATENÇÃO À SAÚDE DA CAMINHONEIRA E CAMINHONEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

## **Módulo V**

**As Violências nas Estradas no Contexto  
de Vida de Caminhoneiras e  
Caminhoneiros**

## AUTORAS

Karolayne Da Cunha Gonsalves – <http://lattes.cnpq.br/2871260889248724>

Rochele Fellini Fachinetto – <http://lattes.cnpq.br/4803135608733740>

### SUMÁRIO

#### ***5.1 Conceitos de violência***

##### ***5.1.1 Tipos de violências***

#### ***5.2 Violência de gênero e comportamentos de risco relacionados às masculinidades***

#### ***5.3 Causas externas: acidentes de trânsito, homicídios e suicídios***

##### ***5.3.1 Acidentes de trânsito***

##### ***5.3.2 Homicídios e violências interpessoais***

##### ***5.3.3 Suicídio e sofrimento psíquico***

##### ***5.3.4 Fatores de risco e de proteção e implicações para a Atenção Primária à Saúde***

#### ***5.4 Acolhimento, cuidado e/ou encaminhamento nos casos de violência e notificação compulsória***

##### ***5.4.1 Acolhimento e escuta qualificada***

##### ***5.4.2 Cuidado integral***

##### ***5.4.3 Encaminhamento e articulação em rede***

##### ***5.4.4 Notificação compulsória***

#### ***5.5 Manejo de grupos, espaços de escuta e atividades coletivas e educativas***

##### ***5.5.1 Grupos e atividades coletivas na Atenção Primária à Saúde***

##### ***5.5.2 Espaços de escuta e diálogo***

##### ***5.5.3 Ações educativas em saúde***

##### ***5.5.4 O papel dos profissionais de saúde e o potencial das ações coletivas***

## APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Prezado profissional estudante, chegamos à última etapa do Curso de Atenção à Saúde da Caminhoneira e Caminhoneiro na Atenção Primária. Bem-vindo ao Módulo V!

Ao longo deste curso, você percorreu diferentes dimensões do cuidado à caminhoneira e ao caminhoneiro na Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo o cuidado integral, as infecções sexualmente transmissíveis, a saúde mental e as condições crônicas. Neste módulo, abordaremos um tema transversal a todos esses aspectos: **as violências no contexto das estradas**.

As violências constituem um fenômeno complexo, relacionado a fatores sociais, culturais e econômicos, com impactos diretos na saúde e no bem-estar. No contexto das estradas, podem se manifestar de diferentes formas, como acidentes de trânsito, violências interpessoais, violências de gênero e situações de sofrimento psíquico, incluindo o suicídio.

Além disso, aspectos relacionados às masculinidades e às condições de vida e trabalho das caminhoneiras e dos caminhoneiros podem influenciar comportamentos, formas de cuidado e exposição a riscos, tornando esse tema ainda mais relevante para a prática em saúde.

Nesse cenário, a APS ocupa um papel estratégico na identificação, no acolhimento e no acompanhamento das pessoas em situação de violência. A escuta qualificada, o cuidado integral, a articulação com a rede de serviços e as ações de prevenção são fundamentais para o enfrentamento dessas circunstâncias.

Ao final deste módulo, esperamos que você seja capaz de reconhecer as diferentes formas de violências no contexto das estradas e refletir sobre estratégias de cuidado e prevenção no âmbito da APS, contribuindo para práticas mais sensíveis, integradas e comprometidas com a proteção e a promoção da saúde.

Você está pronto para seguir sua última viagem deste curso?

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Compreender as diferentes formas de violências no contexto das estradas como fenômenos sociais e determinantes do processo saúde-doença.

2. Analisar as violências de gênero e os comportamentos de risco associados às masculinidades, considerando a influência de normas sociais e as repercussões na Saúde.
3. Identificar causas externas dos acidentes de trânsito, homicídios e suicídios, bem como fatores de risco e de proteção no contexto da APS.
4. Analisar estratégias de acolhimento, escuta qualificada, encaminhamento e notificação de situações de violências no âmbito da APS.
5. Reconhecer a importância das ações educativas e coletivas, bem como dos espaços de escuta voltados à prevenção das violências e à promoção do cuidado de caminhoneiras e caminhoneiros.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>CARGA HORÁRIA DE ESTUDO</b> |
|--------------------------------|

07 horas.

## 5.1 Conceitos de violência

Você já parou para pensar no que é violência? Será que ela se resume apenas a agressões físicas?

No senso comum, muitas vezes associamos violência a situações visíveis, como brigas ou agressões. No entanto, a violência é um fenômeno muito mais amplo, complexo e presente no nosso cotidiano. No campo das ciências sociais, a violência é compreendida como um fenômeno histórico e social, que envolve relações de poder, normas culturais, conflitos e desigualdades. Isso significa que aquilo que entendemos como violência pode variar de acordo com o contexto, a época e a sociedade. Ou seja, a violência não é apenas um ato isolado ou individual: ela é construída socialmente.

De forma mais abrangente, a violência pode ser definida como uma relação social marcada pelo uso da força ou da coerção, que impede o reconhecimento do outro como sujeito de direitos, provocando danos e situando-se como oposta aos princípios de uma sociedade democrática (Tavares dos Santos, 2009). Além disso, você consegue imaginar quantas formas de violências existem?

Segundo Tavares dos Santos (2009), as violências se manifestam de formas múltiplas e estão presentes em diferentes dimensões da vida social. Como destaca o autor:

Os fenômenos da violência adquirem novos contornos, passando a disseminar-se por toda a sociedade contemporânea: a multiplicidade das formas de violência — violência política, costumeira, violência de gênero, violência sexual, racista, ecológica, simbólica e violência na escola — configuram-se como um processo de dilaceramento da cidadania. (Tavares dos Santos, 2009, p. 16)

Isso nos mostra que as violências vão muito além do que é visível, podendo ser tanto física quanto simbólica, psicológica e institucional, entre outras formas. Misse (2016) também chama atenção para um aspecto importante: na sociedade contemporânea, o termo “violência” vem sendo ampliado, passando a incluir situações que antes não eram reconhecidas como tal. Sendo assim, é importante analisar cada situação considerando seu contexto e suas especificidades. Por isso, nos próximos tópicos vamos compreender os tipos de violências, as violências no contexto da estrada e por que isso importa para a saúde.

### 5.1.1 Tipos de violências

Para ajudar a identificar essas diferentes formas, vamos olhar para um exemplo importante da legislação brasileira. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu Artigo 7º, define diferentes formas de violência contra a mulher. Essa lei descreve os tipos de violência conforme exposto a seguir.

- **Violência física:** qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal.
- **Violência psicológica:** ações que causem dano emocional, diminuição da autoestima ou controlem comportamentos.
- **Violência sexual:** qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada.
- **Violência patrimonial:** retenção, destruição ou subtração de bens, documentos ou recursos.
- **Violência moral:** calúnia, difamação ou injúria.

Agora, pense: você já tinha considerado todas essas situações como violência? Esse exemplo ajuda a perceber como as violências podem se manifestar de maneiras diversas, muitas vezes silenciosas ou naturalizadas no cotidiano.

## 5.2 Violências de gênero e comportamentos de risco relacionados às masculinidades

Quando falamos em violências de gênero, o que vem à sua mente?

A princípio, é importante ressaltar que a violência de gênero não é um fenômeno isolado; ela está diretamente relacionada às formas como a sociedade constrói e organiza as relações entre homens e mulheres. Como aponta Scott (1995), o gênero é uma categoria fundamental para compreender as relações de poder, influenciando comportamentos, práticas e instituições. Isso significa que as violências de gênero são expressões dessas desigualdades, e estão presentes em diferentes espaços, inclusive nas estradas.

No Brasil, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) reconhece a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos e, como vimos, mostra que ela pode se manifestar de várias formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Mas você já parou para pensar como isso aparece no cotidiano das estradas? Embora a profissão de caminhoneiro seja historicamente associada aos homens, cada vez mais mulheres ocupam esse espaço. No entanto, elas ainda enfrentam muitos desafios, como:

- preconceito por atuarem em uma profissão considerada “masculina”;
- situações de assédio moral e sexual;
- insegurança em pontos de parada;
- invisibilidade e falta de reconhecimento profissional.

Agora, vamos olhar para outro ponto importante: as masculinidades!

Você já pensou como as expectativas sociais sobre “ser homem” podem influenciar comportamentos?

Segundo Connell (2005), as masculinidades são construções sociais, ou seja, não existe apenas uma forma de ser homem, mas várias. No entanto, há um modelo dominante, chamado de masculinidade hegemônica, que valoriza atributos como força, resistência, autonomia e controle emocional. Connell e Pearse (2015) destacam que essas normas não apenas orientam comportamentos, mas também criam expectativas sociais — o que pode ter consequências importantes para a saúde. No contexto das estradas, essas expectativas podem aparecer em situações como:

- resistência em reconhecer cansaço ou adoecimento;
- valorização da resistência física extrema;
- uso de álcool e outras drogas como forma de lidar com o estresse;
- dificuldade em buscar ajuda ou acessar serviços de saúde.

Como apontam Costa (2003) e Toneli, Souza e Müller (2010), essas práticas podem aumentar a exposição dos homens a riscos e agravos à saúde, além de dificultar o cuidado. Mais do que influenciar comportamentos de risco, as normas rígidas de masculinidade também inserem os homens em contextos de violência, tanto como autores quanto como vítimas. Segundo o Ministério da Saúde (2025), os homens, especialmente jovens, negros e socialmente vulnerabilizados, são os que mais sofrem e também os que mais praticam violências, como agressões e homicídios. Esse fenômeno está relacionado à socialização masculina hegemônica, que associa o “ser homem” à demonstração de força, coragem, domínio e disposição para enfrentar riscos, o que favorece a naturalização da violência como forma de resolver conflitos e afirmar identidades.

Ao mesmo tempo, essas normas dificultam o reconhecimento do sofrimento, a busca por ajuda e o acesso aos serviços de saúde, impactando diretamente os processos de saúde e adoecimento, o que reforça a importância de incluir os homens nas ações de prevenção das violências e de promoção do cuidado. Como destacam Vasconcelos, Seffner e Melo (2020), é preciso reconhecer que existem múltiplas formas de viver as masculinidades, atravessadas por diferentes contextos, trajetórias e condições de vida.

Na APS, compreender essas questões é fundamental. Isso significa:

- reconhecer de que maneira normas de gênero influenciam comportamentos e riscos;
- acolher sem julgamento;
- criar espaços de escuta e diálogo;

- promover reflexões sobre cuidado e saúde.

Mais do que isso, significa entender que essas construções podem ser transformadas, e que o cuidado em saúde também pode contribuir para isso.

**Compreender a relação entre violência de gênero e masculinidades, portanto, é um passo essencial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção da saúde que sejam efetivas, contextualizadas e comprometidas com a equidade.**

Ao longo deste tópico, vimos como as violências de gênero e as masculinidades estão presentes no cotidiano das estradas e impactam diretamente a saúde. Mas essas situações também se conectam a consequências concretas, como acidentes, agressões e sofrimento psíquico. No próximo tópico, vamos aprofundar essa discussão analisando as chamadas causas externas, como acidentes de trânsito, homicídios e suicídios, e sua relação com esses contextos.

### **5.3 Causas externas: acidentes de trânsito, homicídios e suicídios**

As causas externas constituem um importante grupo de agravos à saúde, englobando eventos como acidentes de trânsito, violências interpessoais (incluindo homicídios) e lesões autoprovocadas (como o suicídio). De acordo com a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Brasil, 2017), esses eventos representam uma das principais causas de adoecimento e morte no País, especialmente entre homens jovens e adultos.

No contexto das estradas, as causas externas assumem particular relevância, uma vez que as condições de trabalho e de vida das caminhoneiras e dos caminhoneiros podem ampliar a exposição a diferentes fatores de risco, exigindo uma abordagem integrada por parte dos serviços de saúde, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS).

#### **5.3.1 Acidentes de trânsito**

Os acidentes de trânsito configuram-se como uma das principais causas de morbimortalidade associadas às estradas. Esses eventos não devem ser compreendidos como “acidentais”, no sentido de inevitáveis, mas como fenômenos preveníveis, resultantes da interação entre fatores humanos, ambientais e estruturais. Entre os principais fatores de risco no contexto das estradas, destacam-se:

- fadiga decorrente de longas jornadas de trabalho;

- privação de sono;
- uso de álcool e outras drogas;
- condições precárias das vias e dos veículos;
- pressão por prazos e produtividade.

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Brasil, 2017) enfatiza que a prevenção desses eventos exige ações intersetoriais, envolvendo não apenas o setor saúde, mas também políticas de transporte, trabalho e segurança.

### ***5.3.2 Homicídios e violências interpessoais***

Os homicídios representam uma das formas mais graves de violência interpessoal, estando frequentemente associados a contextos de desigualdade social, conflitos, criminalidade e disputas territoriais. No ambiente das estradas, podem estar relacionados a situações como assaltos, conflitos entre motoristas, violências próximas aos Pontos de Parada e Descanso (PPD) e outras interações marcadas por tensão e vulnerabilidade.

Além disso, é importante considerar como normas de gênero e modelos de masculinidade podem influenciar comportamentos agressivos e a resolução de conflitos por meio da violência. Conforme discutido por Costa (2003) e Toneli, Souza e Müller (2010), determinadas construções de masculinidade podem valorizar atitudes de enfrentamento, impulsividade e afirmação de poder, contribuindo para maior exposição a situações de violência, seja como autores, seja como vítimas.

Você consegue perceber, nas situações vivenciadas no cotidiano das estradas, de que maneira as normas sociais e expectativas relacionadas à masculinidade podem influenciar o modo como os conflitos são percebidos e enfrentados?

Sabendo disso, como você — enquanto profissional e junto com sua equipe — pode contribuir para a promoção de interações mais seguras e não violentas nesses contextos?

### ***5.3.3 Suicídio e sofrimento psíquico***

O suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial e prevenível, que deve ser compreendido a partir das condições de vida, trabalho e saúde mental, especialmente no contexto das estradas. Entre caminhoneiras e caminhoneiros, fatores como isolamento social, longos períodos longe da família, pressão por produtividade, privação de sono e uso de álcool e outras drogas podem aumentar o sofrimento psíquico e o risco de comportamento suicida.

Diante desse cenário, campanhas como Setembro Amarelo ganham destaque como estratégias importantes de sensibilização e promoção da saúde mental. No contexto das

estradas, essas ações podem incluir rodas de conversa em PPD, distribuição de materiais educativos, abordagens breves em saúde mental e fortalecimento de espaços de escuta. Além disso, é fundamental que profissionais da Atenção Primária à Saúde estejam atentos a sinais como mudanças de comportamento, uso abusivo de substâncias, queixas inespecíficas e relatos de sofrimento, atuando de forma acolhedora, sem julgamento, e realizando os encaminhamentos necessários.

Na sua prática profissional, como você poderia contribuir para a prevenção do suicídio entre caminhoneiras e caminhoneiros?

Refletir sobre essa questão é essencial. Pequenas ações, como escutar com atenção, acolher o sofrimento e orientar sobre possibilidades de cuidado, podem fazer grande diferença. Nesse sentido, a APS, devido à sua proximidade com o território e com as pessoas, ocupa um lugar estratégico na identificação precoce e no cuidado contínuo, contribuindo para a valorização da vida e a redução de agravos relacionados à saúde mental.

#### ***5.3.4 Fatores de risco e de proteção e implicações para a Atenção Primária à Saúde***

A compreensão das causas externas no contexto das estradas exige análise de fatores de risco e de proteção que influenciam a ocorrência desses eventos.

#### **Quadro 1. Fatores de risco e proteção**

| <b>Fatores de risco</b>                                 | <b>Fatores de proteção</b>                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Condições precárias de trabalho                         | Acesso a serviços de saúde, especialmente na APS   |
| Jornadas extensas e exaustivas                          | Redes de apoio social e familiar                   |
| Uso de substâncias psicoativas                          | Políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador |
| Isolamento social                                       | Ações educativas e de promoção da saúde            |
| Normas de gênero que incentivam comportamentos de risco | Espaços de escuta e acolhimento                    |

Fonte: elaboração das autoras, 2026.

A linha de cuidado para a atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência (Brasil, 2011) destaca o papel estratégico da APS na identificação precoce, no acolhimento e no acompanhamento de pessoas expostas a causas externas. Nesse sentido, os profissionais de saúde devem estar atentos aos sinais de vulnerabilidade, aos fatores de risco e às condições de vida dos usuários, adotando uma abordagem integral que considere não apenas os agravos físicos, mas também os aspectos sociais e emocionais envolvidos.

É fundamental analisar as causas externas como fenômenos preveníveis e socialmente determinados para que ocorra o desenvolvimento de estratégias eficazes de cuidado, promoção da saúde e prevenção das violências no contexto das estradas.

#### **5.4 Acolhimento, cuidado e/ou encaminhamento nos casos de violências e notificação compulsória**

O enfrentamento das violências no âmbito da saúde exige uma abordagem integral, intersetorial e sensível, que considere as múltiplas dimensões envolvidas nas situações de violência. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) desempenha um papel fundamental, sendo frequentemente a porta de entrada preferencial do sistema de saúde e um espaço estratégico para a identificação, o acolhimento e o acompanhamento das pessoas em situação de violência.

Considerando o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento das violências, reflita: como você e sua equipe têm contribuído, nos processos de trabalho, para identificar, acolher e acompanhar pessoas em situação de violência de forma integral e sensível?

##### ***5.4.1 Acolhimento e escuta qualificada***

O acolhimento constitui uma diretriz central das práticas na APS e deve ser compreendido como uma postura ética e relacional, que envolve escuta atenta, respeito, não julgamento e reconhecimento das necessidades dos usuários.

De acordo com a linha de cuidado para a atenção integral à saúde de pessoas em situação de violência (Brasil, 2011), a escuta qualificada é essencial para a identificação de situações de violência, muitas vezes não explicitadas de forma direta. Isso implica:

- criar um ambiente de confiança e privacidade;
- garantir sigilo das informações;
- respeitar o tempo e a autonomia da pessoa;
- evitar atitudes culpabilizadoras ou moralizantes;
- reconhecer sinais físicos, emocionais e comportamentais.

Com isso, a escuta qualificada permite não apenas compreender a situação vivenciada, mas também fortalecer o vínculo entre profissional e usuário, elemento fundamental para a continuidade do cuidado.

#### **Saiba mais**

Acesse o material *Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência*, desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil, em 2011, e conheça mais a fundo as orientações para gestores e profissionais da saúde.

Disponível

em:

[www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/publicacoes/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias-orientacao-para-gestores-e-profissionais-de-saude/view](http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/publicacoes/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias-orientacao-para-gestores-e-profissionais-de-saude/view)

#### **5.4.2 Cuidado integral**

O cuidado às pessoas em situação de violência deve ser orientado pelos princípios da integralidade e da humanização, considerando as dimensões física, psicológica e social do sofrimento. A atenção deve incluir:

- avaliação clínica e manejo das necessidades imediatas;
- atenção à saúde mental;
- apoio emocional;
- orientação sobre direitos e possibilidades de proteção;
- construção conjunta de um plano de cuidado.

É importante reconhecer que o cuidado não se limita ao atendimento pontual, envolvendo também o acompanhamento longitudinal que respeite o contexto de vida da pessoa e suas escolhas. No caso de violência contra a mulher, a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) reforça a necessidade de uma abordagem articulada entre os serviços de saúde e a rede de proteção, reconhecendo a violência como uma violação de direitos humanos e estabelecendo mecanismos para sua prevenção e enfrentamento.

#### **Reflexão**

No cotidiano da Atenção Primária à Saúde, como você tem considerado as dimensões físicas, emocionais e sociais no atendimento dessas pessoas? De que forma sua prática tem contribuído para a construção de vínculos, o respeito às escolhas do usuário e a articulação com a rede de proteção, especialmente nos casos de violência contra a mulher?

Cuidar de pessoas em situação de violência exige mais do que intervenções pontuais: requer escuta qualificada, sensibilidade e compromisso com a integralidade do cuidado.

#### **5.4.3 Encaminhamento e articulação em rede**

Devido à sua complexidade, o enfrentamento das violências exige atuação intersetorial. Nesse contexto, a APS deve atuar de forma articulada com outros pontos da rede de atenção e com serviços de diferentes setores, como assistência social, segurança pública e sistema de justiça. O encaminhamento deve ser realizado de forma responsável e compartilhada, considerando:

- avaliação do risco e da segurança da pessoa;
- consentimento do usuário, sempre que possível;
- oferta de informações claras sobre os serviços disponíveis;
- acompanhamento dos encaminhamentos realizados.

A articulação em rede é fundamental para garantir a continuidade do cuidado e a proteção das pessoas em situação de violência.

#### **5.4.4 Notificação compulsória**

A notificação compulsória de violências é uma importante ferramenta de vigilância em saúde, contribuindo para a visibilidade do problema e para o planejamento de políticas públicas. De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2011), os casos suspeitos ou confirmados de violência devem ser notificados pelos serviços de saúde, independentemente da vontade da vítima, conforme a legislação vigente. Essa notificação:

- não envolve a identificação o profissional;
- não se confunde com denúncia policial;
- visa à proteção da pessoa e à produção de informações epidemiológicas.

**Lembre-se: a notificação permite identificar padrões, grupos mais vulneráveis e territórios com maior ocorrência de violências, subsidiando ações de prevenção e organização da rede de cuidado.**

Apesar dos avanços normativos, o cuidado às pessoas em situação de violência ainda enfrenta desafios no cotidiano dos serviços de saúde, como dificuldades na identificação dos casos, insegurança dos profissionais e limitações na articulação em rede. Nesse sentido, é fundamental investir na formação das equipes, na construção de fluxos de atendimento e no fortalecimento de espaços de discussão e apoio institucional.

Com isso, a atuação qualificada na APS, baseada no acolhimento, na escuta e na articulação intersetorial, tem potencial para contribuir significativamente para o enfrentamento das violências, a proteção das pessoas e a promoção da saúde.

### **5.5 Manejo de grupos, espaços de escuta e atividades coletivas e educativas**

O enfrentamento das violências no contexto das estradas não se limita ao atendimento individual, sendo fundamental o desenvolvimento de estratégias coletivas que promovam o diálogo, a reflexão crítica e o fortalecimento de redes de apoio. Nesse sentido, as ações grupais e educativas e os espaços de escuta configuram-se como importantes dispositivos no âmbito da APS.

Essas estratégias possibilitam a construção de vínculos, a troca de experiências e a problematização de temas sensíveis, como violência, gênero, masculinidades, uso de álcool e outras drogas, saúde mental e condições de trabalho nas estradas.

#### ***5.5.1 Grupos e atividades coletivas na Atenção Primária à Saúde***

Os grupos podem ser utilizados como espaços de cuidado, educação em saúde e promoção de autonomia, favorecendo a participação ativa dos sujeitos. No contexto de caminhoneiras e caminhoneiros, esses espaços podem ser organizados em unidades de saúde, pontos de apoio nas estradas ou em articulação com outros serviços e instituições.

Entre os objetivos das atividades coletivas, destacam-se:

- promover a reflexão sobre comportamentos de risco e práticas de cuidado;
- discutir normas de gênero e masculinidades, ampliando possibilidades de expressão e cuidado;
- fortalecer redes de apoio e solidariedade;
- compartilhar informações sobre saúde, direitos e acesso a serviços;
- prevenir situações de violências e seus agravos.

É importante que esses espaços sejam conduzidos de forma participativa, valorizando os saberes e as experiências dos participantes, evitando abordagens prescritivas ou moralizantes.

### ***5.5.2 Espaços de escuta e diálogo***

A criação de espaços de escuta qualificada em grupo permite que temas frequentemente silenciados possam emergir, contribuindo para a identificação de situações de violências e sofrimento psíquico. Esses espaços devem garantir:

- ambiente acolhedor, respeitoso e livre de julgamentos;
- confidencialidade e segurança para os participantes;
- incentivo à fala e ao compartilhamento de experiências;
- mediação cuidadosa por parte dos profissionais.

No caso das pessoas caminhoneiras, esses espaços podem ser particularmente importantes para enfrentar o isolamento social e favorecer a construção de vínculos, reduzindo sentimentos de solidão e desamparo.

### ***5.5.3 Ações educativas em saúde***

As ações educativas devem ser compreendidas como processos dialógicos, que vão além da transmissão de informações. Inspiradas nos princípios da educação popular em saúde, essas práticas devem estimular a reflexão crítica sobre as condições de vida, trabalho e saúde. No contexto das violências nas estradas, as ações educativas podem abordar temas como:

- prevenção de acidentes de trânsito;
- uso de álcool e outras drogas;
- saúde mental e estratégias de cuidado;
- violência de gênero e relações interpessoais;
- homens aliados na prevenção de violências — adotar a Campanha Laço Branco;
- direitos e acesso à rede de proteção.

Essas ações podem ser realizadas por meio de rodas de conversa, oficinas, campanhas, materiais educativos e intervenções em espaços estratégicos, como postos de combustível e PPD.

### ***5.5.4 O papel dos profissionais de saúde e o potencial das ações coletivas***

Os profissionais da APS atuam como facilitadores das estratégias mencionadas, sendo responsáveis por criar condições para o diálogo, estimular a participação e mediar conflitos quando necessário. Isso exige habilidades como escuta qualificada, sensibilidade às questões de gênero e compreensão dos contextos sociais dos participantes.

Além disso, é fundamental que os profissionais reconheçam os limites de sua atuação, articulando-se com a rede de serviços quando identificadas situações que demandem acompanhamento individual ou encaminhamento.

As atividades coletivas e os espaços de escuta têm um importante potencial transformador, na medida em que contribuem para a construção de novos sentidos sobre saúde, cuidado e relações sociais. Ao problematizar normas de gênero, comportamentos de risco e práticas naturalizadas, essas estratégias podem favorecer mudanças individuais e coletivas, fortalecendo o enfrentamento das violências.

Considerando as atividades coletivas e os espaços de escuta, como você tem exercido seu papel de facilitador do diálogo, promovendo a escuta qualificada, a problematização de normas de gênero e a participação dos usuários? De que forma sua equipe tem articulado essas práticas com a rede de serviços para ampliar o cuidado e o enfrentamento das violências?

Diante do exposto, concluímos que o manejo de grupos e o desenvolvimento de ações educativas no contexto das estradas constituem ferramentas essenciais para a promoção da saúde, a prevenção das violências e a ampliação do cuidado às caminhoneiras e aos caminhoneiros.

## ENCERRAMENTO DO MÓDULO

Ao longo deste módulo você percorreu diferentes dimensões das violências no contexto das estradas, compreendendo que elas não são eventos isolados, mas fenômenos complexos, relacionados às condições de vida, trabalho e saúde da população caminhoneira. Vimos que as violências estão conectadas a desigualdades sociais e relações de poder, e que questões como gênero e masculinidades influenciam diretamente comportamentos, formas de cuidado e exposição a riscos. Também refletimos sobre as chamadas causas externas, como acidentes de trânsito, homicídios e suicídios, entendendo que esses eventos são preveníveis e demandam atenção no campo da saúde.

No campo da prática, você foi convidado a pensar sobre o papel da Atenção Primária à Saúde no acolhimento, na escuta qualificada, no cuidado integral e no encaminhamento das pessoas em situação de violência, além da importância da notificação para dar visibilidade a esses casos e fortalecer as ações de vigilância em saúde. Por fim, discutimos como as ações coletivas e educativas e os espaços de escuta podem contribuir para a promoção da saúde, o fortalecimento de vínculos e a prevenção das violências, especialmente em contextos marcados pelo isolamento, como o das estradas.

Agora, fica o convite à reflexão: como essas informações podem transformar a sua prática? No seu território, quais estratégias você pode fortalecer ou implementar para acolher, cuidar e prevenir situações de violências entre caminhoneiras e caminhoneiros? Lembre-se de que sua atuação — pautada na escuta, no cuidado e no compromisso com a vida — pode fazer a diferença.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 8 ago. 2006a. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm). Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Prevenção do suicídio**: manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2006b. Disponível em: [https://cvv.org.br/wp-content/uploads/2023/08/manual\\_prevencao\\_suicidio\\_profissionais\\_sau\\_de.pdf](https://cvv.org.br/wp-content/uploads/2023/08/manual_prevencao_suicidio_profissionais_sau_de.pdf). Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência**: orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: [www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/publicacoes/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias-orientacao-para-gestores-e-profissionais-de-saude/view](http://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/publicacoes/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias-orientacao-para-gestores-e-profissionais-de-saude/view). Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Anexo VII: Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 3 out. 2017. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002\\_03\\_10\\_2017.html#ANEXOVI](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html#ANEXOVI). Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **O cuidado à saúde do homem em contexto de violência e a proteção de meninas e mulheres no âmbito da APS**: caderno didático do curso [recurso eletrônico]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado\\_saude\\_homem\\_contexto\\_violencia.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_saude_homem_contexto_violencia.pdf). Acesso em: 21 maio 2026.

CONNELL, R. **Masculinities**. 2. ed. Berkeley: University of California Press, 2005.

CONNELL, R. **Gênero em termos reais**. São Paulo: nVersos Editora, 2016.

CONNELL, R.; PEARSE, R. **Gênero**: uma perspectiva global. São Paulo: nVersos Editora, 2015.

COSTA, R. G. Saúde e masculinidade: reflexões de uma perspectiva de gênero. **Revista Brasileira de Estudos de População**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 79-92, 2003. Disponível em: <http://rebep.org.br/revista/article/view/305>. Acesso em: 21 maio 2026.

MISSE, M. Violência e teoria social. **Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 45-63, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7672>. Acesso em: 21 maio 2026.

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. **Revista Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. Disponível em: [https://archive.org/stream/scott\\_gender#page/n8/mode/1up](https://archive.org/stream/scott_gender#page/n8/mode/1up). Acesso em: 21 maio 2026.

TAVARES DOS SANTOS, J. V. **Violências e conflitualidades**. Porto Alegre: Tomo editorial, 2009.

TONELI, M. J. F.; SOUZA, M. G. C.; MÜLLER, R. Masculinidades e práticas de saúde: retratos da experiência de pesquisa em Florianópolis/SC. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 973-994, 2010. Disponível em: [www.scielo.br/j/physis/a/VZK8T9ZQw5Cr6W7ZpW8wzFp/?lang=pt](http://www.scielo.br/j/physis/a/VZK8T9ZQw5Cr6W7ZpW8wzFp/?lang=pt). Acesso em: 21 maio 2026.

VASCONCELOS, M. F. F.; SEFFNER, F.; MELO, M. R. “Gente é mais que homem”: gênero e cuidados em álcool e outras drogas. **Educar em Revista**, v. 36, e75406, 2020. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/1e17/6ee6cc7d10bb993553e11ec9bfcc3c27a474.pdf>. Acesso em: 21 maio 2026.